

QCM pédiatrie

01.06.2018

Pour voter <https://pingo.upb.de>

Numéro de session

993550

Prologue

- C'est votre deuxième session de pédiatrie de la journée
 1. J'adore ca, ca tombe bien!
 2. Franchement? Deux de suites?
 3. C'est l'heure du café/ ou de la sieste
 4. Chic, on va pouvoir comparer les tuteurs
 5. C'est quoi, la pédiatrie?

1

Vous êtes appelés à la maternité pour examiner un nouveau-né. Il présente un poids de naissance en-dessous du 5^{ème} percentile, des petites fentes palpébrales, une microcéphalie et un philtrum plat. Parmi les substances ci-dessous, quelle est celle avec laquelle la mère a été le plus probablement en contact durant sa grossesse?

1. Plomb
2. Mercure
3. Alcool
4. Benzène
5. Monoxyde de carbone

1

Vous êtes appelés à la maternité pour examiner un nouveau-né. Il présente un poids de naissance en-dessous du 5^{ème} percentile, des petites fentes palpébrales, une microcéphalie et un philtrum plat. Parmi les substances ci-dessous, quelle est celle avec laquelle la mère a été le plus probablement en contact durant sa grossesse?

1. Plomb
2. Mercure
3. Alcool
4. Benzène
5. Monoxyde de carbone

2

Jason, âgé de 8 mois, est connu depuis la naissance pour une tétralogie de Fallot. Sa mère remarque soudain qu'il devient tout gris alors qu'elle était en salle d'attente de consultation de cardiologie. Jason est positionné en position genou-pectorale mais cela ne change rien.

Sélectionner dans la liste ci-dessous le traitement approprié de cette crise:

1. Perfusion de prostaglandines
2. Immersion du visage dans de l'eau glacée
3. Béta-bloquant intra-veineux
4. Antibiotiques intra veineux
5. Choc électrique

2

Jason, âgé de 8 mois, est connu depuis la naissance pour une tétralogie de Fallot. Sa mère remarque soudain qu'il devient tout gris alors qu'elle était en salle d'attente de consultation de cardiologie. Jason est positionné en position genou-pectorale mais cela ne change rien.

Sélectionner dans la liste ci-dessous le traitement approprié de cette crise:

1. Perfusion de prostaglandines
2. Immersion du visage dans de l'eau glacée
3. **Béta-bloquant intra-veineux**
4. Antibiotiques intra veineux
5. Choc électrique

3

Un garçon de 18 mois en bon état général présente depuis quelque semaines un écoulement jaune-verdâtre, d'odeur fétide, provenant de la narine droite.

Quel est le diagnostic le plus vraisemblable?

1. une sinusite maxillaire droite
2. une sinusite ethmoïdale droite
3. un corps étranger dans la narine droite
4. une hyperplasie adénoïdienne avec adénoïdite
5. une tumeur dans la narine droite

3

Un garçon de 18 mois en bon état général présente depuis quelque semaines un écoulement jaune-verdâtre, d'odeur fétide, provenant de la narine droite.

Quel est le diagnostic le plus vraisemblable?

1. une sinusite maxillaire droite
2. une sinusite ethmoïdale droite
3. un corps étranger dans la narine droite
4. une hyperplasie adénoïdienne avec adénoïdite
5. une tumeur dans la narine droite

4

Vous évaluez un nourrisson de 3 semaines qui présente des selles défectueuses fréquentes, mêlées à du sang ; la prise pondérale est faible ; une colite est suspectée. L'enfant est exclusivement allaité.

Que faites-vous pour déterminer une éventuelle allergie alimentaire, à l'origine de cette colite ?

1. Dosage des anticorps IgE anti-protéine bovine
2. Test cutané (prick test) avec des protéines bovines
3. Dosage des IgE totales
4. Régime sans protéine bovine chez la mère
5. Dosage des IgE anti-oeufs

4

Vous évaluez un nourrisson de 3 semaines qui présente des selles défectueuses fréquentes, mêlées à du sang ; la prise pondérale est faible ; une colite est suspectée. L'enfant est exclusivement allaité.

Que faites-vous pour déterminer une éventuelle allergie alimentaire, à l'origine de cette colite ?

1. Dosage des anticorps IgE anti-protéine bovine
2. Test cutané (prick test) avec des protéines bovines
3. Dosage des IgE totales
4. Régime sans protéine bovine chez la mère
5. Dosage des IgE anti-oeufs

5

Un nouveau-né de 2 jours présente depuis la naissance une détresse respiratoire s'aggravant progressivement. Il a de plus des vomissements à chaque tentative d'alimentation. Il n'a pas émis de méconium. L'anamnèse familiale et la grossesse sont sans particularité. Poids de naissance 3800 g. A l'examen clinique, les fréquences cardiaques et respiratoires sont respectivement à 152/min et 68/min. Un tirage intercostal est présent et l'auscultation des plages pulmonaires révèle un murmure respiratoire diminué au niveau de l'hémithorax gauche. L'abdomen est légèrement excavé et sa palpation ne met pas en évidence d'hépatosplénomégalie. A l'auscultation abdominale, de rares bruits de tonalité normale sont présents. A la radiographie du thorax, un déplacement du médiastin et une zone hyperclaire dans l'hémithorax gauche sont notés.

Quel est le diagnostic le plus vraisemblable?

1. une sténose hypertrophique du pylore
2. une hernie hiatale
3. une fistule trachéo-oesophagienne
4. une maladie à membranes hyalines
5. une hernie diaphragmatique

5

Un nouveau-né de 2 jours présente depuis la naissance une détresse respiratoire s'aggravant progressivement. Il a de plus des vomissements à chaque tentative d'alimentation. Il n'a pas émis de méconium. L'anamnèse familiale et la grossesse sont sans particularité. Poids de naissance 3800 g. A l'examen clinique, les fréquences cardiaques et respiratoires sont respectivement à 152/min et 68/min. Un tirage intercostal est présent et l'auscultation des plages pulmonaires révèle un murmure respiratoire diminué au niveau de l'hémithorax gauche. L'abdomen est légèrement excavé et sa palpation ne met pas en évidence d'hépatosplénomégalie. A l'auscultation abdominale, de rares bruits de tonalité normale sont présents. A la radiographie du thorax, un déplacement du médiastin et une zone hyperclaire dans l'hémithorax gauche sont notés.

Quel est le diagnostic le plus vraisemblable?

1. une sténose hypertrophique du pylore
2. une hernie hiatale
3. une fistule trachéo-oesophagienne
4. une maladie à membranes hyalines
5. une hernie diaphragmatique

6

Un garçon de 6 ans consulte pour un rash prurigineux de plus de 2 semaines. Le rash augmente et s'aggrave la nuit. Il ne présente pas d'antécédents de maladies cutanées. L'examen physique révèle de nombreuses papules érythémateuses de 2mm de diamètre localisées entre les doigts, dans les plis cutanés, sous les aisselles, à la ceinture, sur le gland et le scrotum.

Quel traitement faut-il prescrire?

- A. Immunoglobulines (IVIg)
- B. Bethamésone topique
- C. Floxapen
- D. Permethrine
- E. Fenystil



6

Un garçon de 6 ans consulte pour un rash prurigineux de plus de 2 semaines. Le rash augmente et s'aggrave la nuit. Il ne présente pas d'antécédents de maladies cutanées. L'examen physique révèle de nombreuses papules érythémateuses de 2mm de diamètre localisées entre les doigts, dans les plis cutanés, sous les aisselles, à la ceinture, sur le gland et le scrotum.

Quel traitement faut-il prescrire?

- A. Immunoglobulines (IVIg)
- B. Bethamésone topique
- C. Floxapen
- D. Permethrine
- E. Fenystil

7

Vous êtes appelé à la maternité pour examiner un nouveau-né. Une fois déshabillé, vous observez un discret ictère. Le nouveau-né ne présente pas de détresse respiratoire et a un bon cri. L'auscultation cardio-pulmonaire est physiologique et le reste de l'examen est sans particularité. L'anamnèse obtenue auprès de la mère semble sans particularité excepté un manque de suivi prénatal. La maman a tout de même eu des sérologies syphilis (négative) et rubéole (immune) et il n'y a pas d'incompatibilité de groupe sanguin. En posant plus de questions à la mère elle admet avoir consommé des drogues par le passé.

Quelle est la condition ci-dessous pour laquelle ce nouveau-né est à risque?

1. Fente palatine
2. Hépatite B
3. Maladie de Niemann-Pick
4. Neuroblastome
5. Malformation rénale

7

Vous êtes appelé à la maternité pour examiner un nouveau-né. Une fois déshabillé, vous observez un discret ictère. Le nouveau-né ne présente pas de détresse respiratoire et a un bon cri. L'auscultation cardio-pulmonaire est physiologique et le reste de l'examen est sans particularité. L'anamnèse obtenue auprès de la mère semble sans particularité excepté un manque de suivi prénatal. La maman a tout de même eu des sérologies syphilis (négative) et rubéole (immune) et il n'y a pas d'incompatibilité de groupe sanguin. En posant plus de questions à la mère elle admet avoir consommé des drogues par le passé.

Quelle est la condition ci-dessous pour laquelle ce nouveau-né est à risque?

1. Fente palatine
2. Hépatite B
3. Maladie de Niemann-Pick (lipidose lysosomale avec ictère et HSM)
4. Neuroblastome
5. Malformation rénale

8

Chez un garçon de 14 ans on trouve une fièvre et une amygdalite caractérisée par la présence de membranes gris-blanchâtres, qu'on peut facilement détacher. Il a des lymphadénopathies généralisées, un exanthème maculo-papulaire, une augmentation des lymphocytes et monocytes dans la formule sanguine.

Quel est le diagnostic le plus probable?

1. une leucémie aiguë
2. une infection à VIH
3. une diphtérie
4. une scarlatine
5. une mononucléose infectieuse

8

Chez un garçon de 14 ans on trouve une fièvre et une amygdalite caractérisée par la présence de membranes gris-blanchâtres, qu'on peut facilement détacher. Il a des lymphadénopathies généralisées, un exanthème maculo-papulaire, une augmentation des lymphocytes et monocytes dans la formule sanguine.

Quel est le diagnostic le plus probable?

1. une leucémie aiguë
2. une infection à VIH
3. une diphtérie
4. une scarlatine
5. une mononucléose infectieuse

9

Une adolescente de 13 ans se présente à votre consultation avec ses parents. Ceux-ci sont inquiets en raison de sa « mauvaise posture ». A l'examen clinique, elle a une asymétrie des épaules, des hanches et une gibbosité apparaît quand elle se penche en avant. Le reste de l'examen clinique est normal.

Les affirmations suivantes concernant la pathologie que présente cette adolescente sont vraies à l'exception de:

1. Elle est idiopathique dans la majorité de cas
2. Elle est plus fréquente à l'âge de l'adolescence
3. Elle est typiquement accompagnée de douleurs et d'une raideur
4. Elle peut être associée à la neurofibromatose, le syndrome de Marfan et à la mucopolysaccharidose

9

Une adolescente de 13 ans se présente à votre consultation avec ses parents. Ceux-ci sont inquiets en raison de sa « mauvaise posture ». A l'examen clinique, elle a une asymétrie des épaules, des hanches et une gibbosité apparaît quand elle se penche en avant. Le reste de l'examen clinique est normal.

Les affirmations suivantes concernant la pathologie que présente cette adolescente sont vraies à l'exception de:

1. Elle est idiopathique dans la majorité de cas
2. Elle est plus fréquente à l'âge de l'adolescence
3. Elle est typiquement accompagnée de douleurs et d'une raideur
4. Elle peut être associée à la neurofibromatose, le syndrome de Marfan et à la mucopolysaccharidose

10 Question k'

Une fillette se présente à votre consultation pour son contrôle des 6 ans. Pendant votre examen clinique, vous mettez en évidence un souffle systolique à l'auscultation cardiaque.

Lesquelles de ces propositions nécessitent une investigation plus poussée ?

1. Un thrill à la palpation
2. Une disparition du souffle en position assise
3. Un souffle diastolique doux associé
4. Une dyspnée à l'exercice

10 Question k'

Une fillette se présente à votre consultation pour son contrôle des 6 ans. Pendant votre examen clinique, vous mettez en évidence un souffle systolique à l'auscultation cardiaque.

Lesquelles de ces propositions nécessitent une investigation plus poussée ?

1. Un thrill à la palpation
2. Une disparition du souffle en position assise
3. Un souffle diastolique doux associé
4. Une dyspnée à l'exercice

11

La mère d'un garçon de 18 mois vous consulte en urgence. Il y a 2 jours, après une réprimande banale, le garçon a paru très contrarié, il s'est mis à pleurer, a fait une véritable crise, il en a perdu le souffle et son visage est devenu tout bleu. Cela a duré environ 1/2 minute. Ce matin dans des circonstances analogues, après s'être mis dans une grande colère, il a fait un épisode identique, mais a perdu connaissance pendant un temps que la maman n'arrive pas à préciser, probablement quelques minutes, sa figure était de nouveau toute bleue.

Quelle est l'attitude correcte du médecin?

1. pratiquer un électroencéphalogramme en urgence
2. pratiquer un ECG et organiser une échographie cardiaque.
3. penser à un trouble du rythme cardiaque
4. penser à une épilepsie et envisager de la traiter
5. rassurer la famille en expliquant la nature et le caractère bénin de ces épisodes

11

La mère d'un garçon de 18 mois vous consulte en urgence. Il y a 2 jours, après une réprimande banale, le garçon a paru très contrarié, il s'est mis à pleurer, a fait une véritable crise, il en a perdu le souffle et son visage est devenu tout bleu. Cela a duré environ 1/2 minute. Ce matin dans des circonstances analogues, après s'être mis dans une grande colère, il a fait un épisode identique, mais a perdu connaissance pendant un temps que la maman n'arrive pas à préciser, probablement quelques minutes, sa figure était de nouveau toute bleue.

Quelle est l'attitude correcte du médecin?

1. pratiquer un électroencéphalogramme en urgence
2. pratiquer un ECG et organiser une échographie cardiaque.
3. penser à un trouble du rythme cardiaque
4. penser à une épilepsie et envisager de la traiter
5. rassurer la famille en expliquant la nature et le caractère bénin de ces épisodes

12

Colin, âgé de 2 semaines, se présente à votre consultation avec des vomissements, des diarrhées et un mauvais appétit. Les examens complémentaires montrent : Na 112 mmol/l (135-145), K 6.4 mmol/l (3.5-6), Urée 7.8 mmol/l (2.5-8), Créatinine 30 micromol/l (20-65), Glycémie 2 mmol/l (3-6). La FSC et CRP sont normales

Quel est le diagnostic le plus probable?

1. Hypothyroïdie
2. Syndrome de Cushing
3. Apports sodés inadéquats
4. Hyperplasie congénitale des surrénales
5. Insuffisance rénale aiguë

12

Colin, âgé de 2 semaines, se présente à votre consultation avec des vomissements, des diarrhées et un mauvais appétit. Les examens complémentaires montrent : Na 112 mmol/l (135-145), K 6.4 mmol/l (3.5-6), Urée 7.8 mmol/l (2.5-8), Créatinine 30 micromol/l (20-65), Glycémie 2 mmol/l (3-6). La FSC et CRP sont normales

Quel est le diagnostic le plus probable?

1. Hypothyroïdie (Ictère, hypotonie, prise de poids rapide)
2. Syndrome de Cushing
3. Apports sodés inadéquats
4. Hyperplasie congénitale des surrénales
5. Insuffisance rénale aiguë

13

Un enfant de 4 ans en bonne santé habituelle mais non vacciné présente un état hautement fébrile d'apparition soudaine accompagnée d'un stridor inspiratoire et d'un refus de boire. L'enfant est très anxieux.

Quelle est, l'attitude la plus raisonnable dans cette situation clinique?

1. Garder l'enfant en position assise
2. Faire un frottis de gorge
3. L'intuber rapidement
4. Faire une radiographie des cervicales
5. Tester sa raideur de nuque

13

Un enfant de 4 ans en bonne santé habituelle mais non vacciné présente un état hautement fébrile d'apparition soudaine accompagnée d'un stridor inspiratoire et d'un refus de boire. L'enfant est très anxieux.

Quelle est, l'attitude la plus raisonnable dans cette situation clinique?

1. Garder l'enfant en position assise
2. Faire un frottis de gorge
3. L'intuber rapidement
4. Faire une radiographie des cervicales
5. Tester sa raideur de nuque

14

Un garçon de 14 ans est amené aux urgences de pédiatrie pour des douleurs dans le bas abdomen avec nausées et vomissements, d'apparition brutale après le cours de gym. A l'examen clinique, les signes vitaux sont normaux et l'abdomen est souple et indolore avec des bruits hydroaériques normaux en tonalité et fréquence.

Quel élément à l'examen clinique vous ferait suspecter une torsion de l'hydatide de Morgani?

1. La disparition de la douleur à l'élévation du scrotum
2. Un œdème scrotal unilatéral et indolore
3. Une tache bleue sur la partie supérieure du testicule
4. L'absence du reflexe crémastérien
5. Un écoulement au niveau du méat urinaire

14

Un garçon de 14 ans est amené aux urgences de pédiatrie pour des douleurs dans le bas abdomen avec nausées et vomissements, d'apparition brutale après le cours de gym. A l'examen clinique, les signes vitaux sont normaux et l'abdomen est souple et indolore avec des bruits hydroaériques normaux en tonalité et fréquence.

Quel élément à l'examen clinique vous ferait suspecter une torsion de l'hydatide de Morgani?

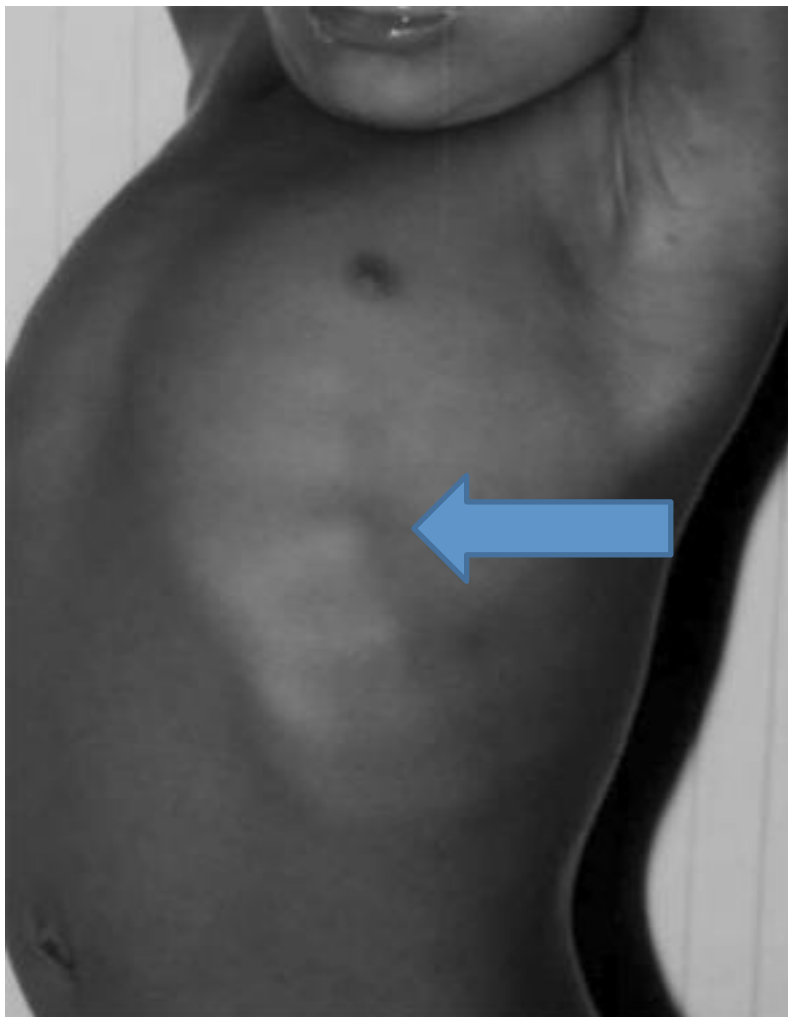
1. La disparition de la douleur à l'élévation du scrotum
2. Un œdème scrotal unilatéral et indolore
3. Une tache bleue sur la partie supérieure du testicule
4. L'absence du reflexe crémastérien
5. Un écoulement au niveau du méat urinaire

15

Un nourrisson de 21 mois est amené à votre consultation par ses parents adoptifs. A l'anamnèse, les parents vous disent que l'enfant n'était pas régulièrement suivi par un pédiatre jusqu'à l'âge de 18 mois et il est né avec un petit poids de naissance. En entrant dans la salle de consultation, l'enfant paraît dénutri. Au status, sa tête vous semble disproportionnée et il présente un épaissement de ses chevilles et poignets. Il présente des protubérances aux jonctions costochondrales. Des radiographies révèlent des épaissement des plateaux épiphysaires.

Quel est le diagnostic le plus probable?

1. Intoxication à la vitamine A
2. Déficit en vitamine D
3. Déficit en thiamine
4. Hypoparathyroïdisme



15

Un nourrisson de 21 mois est amené à votre consultation par ses parents adoptifs. A l'anamnèse, les parents vous disent que l'enfant n'était pas régulièrement suivi par un pédiatre jusqu'à l'âge de 18 mois et il est né avec un petit poids de naissance. En entrant dans la salle de consultation, l'enfant paraît dénutri. Au status, sa tête vous semble disproportionnée et il présente un épaississement de ses chevilles et poignets. Il présente des protubérances aux jonctions costochondrales. Des radiographies révèlent des épaississements des plateaux épiphysaires.

Quel est le diagnostic le plus probable?

1. Intoxication à la vitamine A
2. Déficit en vitamine D
3. Déficit en thiamine (béribéri neuropathies periph, paralysie, insuf ♥)
4. Hypoparathyroïdisme (hypoCa et tétanies)

16

Un garçon de 8 ans en bonne santé habituelle est admis en urgence pour une hémorragie digestive basse massive.

Quelle est la cause la plus probable de ce saignement?

1. Volvulus intestinal
2. Fissure anale
3. Invagination
4. Diverticule de Meckel
5. Varices œsophagiennes

16

Un garçon de 8 ans en bonne santé habituelle est admis en urgence pour une hémorragie digestive basse massive.

Quelle est la cause la plus probable de ce saignement?

1. Volvulus intestinal
2. Fissure anale
3. Invagination
4. Diverticule de Meckel
5. Varices œsophagiennes

17

Une jeune fille de 16 ans vient à votre consultation et se plaint d'une toux principalement nocturne, sans sécrétion de mucus et d'une dyspnée depuis 3 semaines. Elle nie la présence de fièvre ou de douleurs. Néanmoins, elle a éprouvé des symptômes semblables de moindre intensité il y a un an, également au printemps.

Pour confirmer la suspicion diagnostique qui s'impose, quel examen est le plus approprié?

1. une bronchoscopie
2. une spirométrie
3. une radiographie du thorax
4. un test d'effort
5. une formule sanguine complète

17

Une jeune fille de 16 ans vient à votre consultation et se plaint d'une toux principalement nocturne, sans sécrétion de mucus et d'une dyspnée depuis 3 semaines. Elle nie la présence de fièvre ou de douleurs. Néanmoins, elle a éprouvé des symptômes semblables de moindre intensité il y a un an, également au printemps.

Pour confirmer la suspicion diagnostique qui s'impose, quel examen est le plus approprié?

1. une bronchoscopie
2. une spirométrie
3. une radiographie du thorax
4. un test d'effort
5. une formule sanguine complète

18

Une jeune fille de 15 ans se présente avec une éruption par plaque rouge et desquamante sur le nez et les joues. Elle a également des lésions érythémateuses et desquamantes sur la face dorsale des doigts. Les valeurs de laboratoire révèlent une anémie et une protéinurie (photos).

Le diagnostic le plus probable est:

1. Dermatomyosite
2. Arthrite juvénile idiopathique
3. Eczéma atopique
4. Réaction médicamenteuse
5. Lupus erythémateux disséminé



18

Une jeune fille de 15 ans se présente avec une éruption par plaque rouge et desquamante sur le nez et les joues. Elle a également des lésions érythémateuses et desquamantes sur la face dorsale des doigts. Les valeurs de laboratoire révèlent une anémie et une protéinurie (photos).

Le diagnostic le plus probable est:

1. Dermatomyosite
2. Arthrite juvénile idiopathique
3. Eczéma atopique
4. Réaction médicamenteuse
5. Lupus érythémateux disséminé

19

Un enfant de 14 ans se présente à votre consultation avec de la fièvre et des douleurs articulaires depuis 1 semaine. Il se plaint également d'une toux non productive et d'une odynodysphagie.

Parmi les examens ci-dessous lequel est le plus approprié dans la prise en charge initiale de ce patient?

1. Frottis de gorge pour le Streptocoque du groupe A
2. Frottis de gorge pour l'Haemophilus influenzae
3. Radiographie des articulations douloureuses
4. Aspiration à l'aiguille fine des articulations
5. Vitesse de sédimentation

19

Un enfant de 14 ans se présente à votre consultation avec de la fièvre et des douleurs articulaires depuis 1 semaine. Il se plaint également d'une toux non productive et d'une odynodysphagie.

Parmi les examens ci-dessous lequel est le plus approprié dans la prise en charge initiale de ce patient?

1. Frottis de gorge pour le Streptocoque du groupe A
2. Frottis de gorge pour l'Haemophilus influenzae
3. Radiographie des articulations douloureuses
4. Aspiration à l'aiguille fine des articulations
5. Vitesse de sédimentation

20

Lors d'un examen d'entourage d'une famille, effectué à la suite de la découverte d'un cas de tuberculose, un enfant âgé de 7 ans a une réaction à la tuberculine positive, alors qu'il n'a pas reçu le BCG. Sa radiographie thoracique est normale.

Quelle est la mesure la plus appropriée?

1. entreprendre un traitement à base d'INH
2. donner une triple association antituberculeuse (INH, éthambutol, rifampicine)
3. vacciner avec le BCG
4. faire une radiographie de contrôle dans 6 semaines
5. ne rien faire

20

Lors d'un examen d'entourage d'une famille, effectué à la suite de la découverte d'un cas de tuberculose, un enfant âgé de 7 ans a une réaction à la tuberculine positive, alors qu'il n'a pas reçu le BCG. Sa radiographie thoracique est normale.

Quelle est la mesure la plus appropriée?

1. **entreprendre un traitement à base d'INH**
2. donner une triple association antituberculeuse (INH, éthambutol, rifampicine)
3. vacciner avec le BCG
4. faire une radiographie de contrôle dans 6 semaines
5. ne rien faire

21

Lors de l'examen médical à la fin de l'école obligatoire, vous trouvez chez une jeune fille de 16 ans, sans plaintes subjectives, une tension artérielle de 85/50 mmHg. Pour le reste, l'examen clinique est normal.

Il faut recommander à cette jeune fille:

1. consulter son médecin de famille pour une investigation
2. prendre des médicaments qui augmentent la tension artérielle
3. ne pas pratiquer de sport de compétition
4. éviter la haute altitude
5. ne pas s'en préoccuper

21

Lors de l'examen médical à la fin de l'école obligatoire, vous trouvez chez une jeune fille de 16 ans, sans plaintes subjectives, une tension artérielle de 85/50 mmHg. Pour le reste, l'examen clinique est normal.

Il faut recommander à cette jeune fille:

1. consulter son médecin de famille pour une investigation
2. prendre des médicaments qui augmentent la tension artérielle
3. ne pas pratiquer de sport de compétition
4. éviter la haute altitude
5. ne pas s'en préoccuper

22

Une jeune fille de 15 ans se présente en salle d'accouchement à 36 semaines de gestation et raconte qu'elle a perdu les eaux il y a 4 jours. Elle présente de rares contractions utérines, le col est perméable à un doigt, et elle n'a pas eu de fièvre. Le monitoring ne met pas en évidence des signes cardiaques de stress chez le fœtus. Son médecin débute une provocation à l'ocytocine. 10 heures plus tard, elle met au monde une fillette de 3kg, dont le score d'Apgar est de 6 à 1 minute et 9 à 5 minutes.

Le facteur de risque le plus important pour une infection néonatale est:

- A. sexe féminin
- B. âge de la mère
- C. score d'Apgar à 1 minute
- D. rupture prématurée de la poche des eaux
- E. âge gestationnel <37 semaines

22

Une jeune fille de 15 ans se présente en salle d'accouchement à 36 semaines de gestation et raconte qu'elle a perdu les eaux il y a 4 jours. Elle présente de rares contractions utérines, le col est perméable à un doigt, et elle n'a pas eu de fièvre. Le monitoring ne met pas en évidence des signes cardiaques de stress chez le fœtus. Son médecin débute une provocation à l'ocytocine. 10 heures plus tard, elle met au monde une fillette de 3kg, dont le score d'Apgar est de 6 à 1 minute et 9 à 5 minutes.

Le facteur de risque le plus important pour une infection néonatale est:

- A. sexe féminin
- B. âge de la mère
- C. score d'Apgar à 1 minute
- D. rupture prématurée de la poche des eaux
- E. âge gestationnel <37 semaines

23

Dans un camp de réfugiés, vous examinez un garçon de 2 ans qui présente 3 jours de fièvre à 40°C, une toux, une rhinite et une conjonctivite. L'examen clinique révèle une photophobie, une conjonctivite, et un rash maculaire derrière les oreilles, sur le visage et le tronc.

A propos de cette maladie, tout est vrai sauf?

1. C'est une maladie mortelle
2. La contagiosité est très grande
3. Il existe un vaccin contre cette maladie
4. On la traite par antibiotique
5. Il peut y avoir des complications longtemps après

23

Dans un camp de réfugiés, vous examinez un garçon de 2 ans qui présente 3 jours de fièvre à 40°C, une toux, une rhinite et une conjonctivite. L'examen clinique révèle une photophobie, une conjonctivite, et un rash maculaire derrière les oreilles, sur le visage et le tronc.

A propos de cette maladie, tout est vrai sauf?

1. C'est une maladie mortelle
2. La contagiosité est très grande
3. Il existe un vaccin contre cette maladie
4. On la traite par antibiotique
5. Il peut y avoir des complications longtemps après

24

Quelques jours après la résolution d'une infection virale, un garçon de 7 ans se présente aux urgences en raison d'une marche titubante. A l'examen neurologique il présente une ataxie, une anomalie des épreuves doigt-nez et talon-genou.

Quel est le virus le plus probablement en cause?

1. Virus Herpes simplex
2. Virus varicelle-Zoster
3. Cytomégalovirus (CMV)
4. Virus d'Epstein Barr (EBV)
5. Virus Hepatite A

24

Quelques jours après la résolution d'une infection virale, un garçon de 7 ans se présente aux urgences en raison d'une marche titubante. A l'examen neurologique il présente une ataxie, une anomalie des épreuves doigt-nez et talon-genou.

Quel est le virus le plus probablement en cause?

1. Virus Herpes simplex
2. Virus varicelle-Zoster
3. Cytomégalovirus (CMV)
4. Virus d'Epstein Barr (EBV)
5. Virus Hépatite A

25

Un enfant de 4 ans connu pour un reflux vésico-urétéral modéré présente des infections urinaires à répétition malgré une antibioprophylaxie adéquate. Quel est la prise en charge la plus appropriée?

1. Antibiothérapie IV pendant 2 semaines
2. UIV (Urographie intraveineuse)
3. Angiographie rénale
4. Chirurgie anti-reflux
5. Ajouter de la vitamine C à la prophylaxie antibiotique

25

Un enfant de 4 ans connu pour un reflux vésico-urétéral modéré présente des infections urinaires à répétition malgré une antibioprophylaxie adéquate. Quel est la prise en charge la plus appropriée?

1. Antibiothérapie IV pendant 2 semaines
2. UIV (Urographie intraveineuse)
3. Angiographie rénale
4. Chirurgie anti-reflux
5. Ajouter de la vitamine C à la prophylaxie antibiotique

26

Un bébé âgé de 10 jours est amené chez vous. Il est né 15 jours avant terme avec un poids de 2500 g. Il a émis du méconium à 12 heures de vie et s'est alimenté normalement. Depuis ce matin, il présente des vomissements teintés de bile, est apathique, refuse de téter et il a une température de 36 °C. Il n'a pas été à selles depuis 12 heures. A l'examen, son abdomen est souple, mais le bébé gémit quand vous le palpez.
Quel est le diagnostic de présomption?

1. la maladie de Hirschsprung
2. une atrésie intestinale
3. une sténose hypertrophique du pylore
4. un volvulus intestinal
5. une invagination

26

Un bébé âgé de 10 jours est amené chez vous. Il est né 15 jours avant terme avec un poids de 2500 g. Il a émis du méconium à 12 heures de vie et s'est alimenté normalement. Depuis ce matin, il présente des vomissements teintés de bile, est apathique, refuse de téter et il a une température de 36 °C. Il n'a pas été à selles depuis 12 heures. A l'examen, son abdomen est souple, mais le bébé gémit quand vous le palpez.

Quel est le diagnostic de présomption?

1. la maladie de Hirschsprung
2. une atrésie intestinale
3. une sténose hypertrophique du pylore
4. un volvulus intestinal
5. une invagination

27

Un garçon de 13 ans obèse souffre de douleurs à la hanche depuis 2 mois. A l'examen, on met en évidence une diminution de la rotation interne de la hanche gauche.

Quelle est la cause la plus vraisemblable?

1. une épiphysiolyse de la tête fémorale
2. une coxarthrose
3. une tumeur à cellules géantes
4. une arthrite tuberculeuse
5. une dysplasie de hanche

27

Un garçon de 13 ans obèse souffre de douleurs à la hanche depuis 2 mois. A l'examen, on met en évidence une diminution de la rotation interne de la hanche gauche.

Quelle est la cause la plus vraisemblable?

1. une épiphysiolyse de la tête fémorale
2. une coxarthrose
3. une tumeur à cellules géantes
4. une arthrite tuberculeuse
5. une dysplasie de hanche

28

Une enfant de 5 ans est amenée aux urgences pour un état fébrile à 39.6°C dans un contexte de baisse de l'état général, d'irritabilité et de vomissements. Durant les 3 derniers jours elle a reçu de hautes doses d'amoxicilline en raison d'une otite bilatérale. L'examen clinique met en évidence un état fébrile à 40°C, une apparence toxique et une irritabilité. L'examen du liquide céphalo-rachidien documente un glucose diminué à 0.56 mmol/l, des protéines élevées à 1.5gr/l, 620 globules blancs/mm³ avec une prédominance de polymorphonucléaires, pas de globules rouges. A l'examen direct (Gram) il n'y a pas de germes décelables.

Le diagnostic le plus probable est :

1. Méningite à enterovirus
2. Encéphalite herpétique
3. Méningite sur maladie de Lyme
4. Méningite bactérienne décapitée
5. Méningite tuberculeuse

28

Une enfant de 5 ans est amenée aux urgences pour un état fébrile à 39.6°C dans un contexte de baisse de l'état général, d'irritabilité et de vomissements. Durant les 3 derniers jours elle a reçu de hautes doses d'amoxicilline en raison d'une otite bilatérale. L'examen clinique met en évidence un état fébrile à 40°C, une apparence toxique et une irritabilité. L'examen du liquide céphalo-rachidien documente un glucose diminué à 0.56 mmol/l, des protéines élevées à 1.5gr/l, 620 globules blancs/mm³ avec une prédominance de polymorphonucléaires, pas de globules rouges. A l'examen direct (Gram) il n'y a pas de germes décelables.

Le diagnostic le plus probable est :

1. Méningite à enterovirus
2. Encéphalite herpétique
3. Méningite sur maladie de Lyme
4. Méningite bactérienne décapitée
5. Méningite tuberculeuse

29

Un enfant de 12 ans se présente au cabinet en raison de maux de gorge violents. Les jours derniers, il présentait des difficultés à avaler les solides, puis à présent une odynodysphagie aux liquides et à sa salive. Vous le suivez depuis la naissance et tous ses vaccins sont à jour. A l'examen clinique, il est fébrile à 38.9°C, l'amygdale gauche enflée, le voile du palais bombant et la luette déplacée. L'amygdale droite est normale.

Quel est le diagnostic le plus probable?

1. Gingivostomatite herpétique
2. Angine virale
3. Diphtérie
4. Abscess amygdalien
5. Pharyngite

29

Un enfant de 12 ans se présente au cabinet en raison de maux de gorge violents. Les jours derniers, il présentait des difficultés à avaler les solides, puis à présent une odynodysphagie aux liquides et à sa salive. Vous le suivez depuis la naissance et tous ses vaccins sont à jour. A l'examen clinique, il est fébrile à 38.9°C, l'amygdale gauche enflée, le voile du palais bombant et la luette déplacée. L'amygdale droite est normale.

Quel est le diagnostic le plus probable?

1. Gingivostomatite herpétique
2. Angine virale
3. Diphtérie
4. **Abcès amygdalien**
5. Pharyngite

30

Un garçon de 8 ans se présente avec une éruption prurigineuse aiguë sur les bras et les jambes caractérisée par des papules, des tâches et des vésicules alignées de façon linéaire. Il a déjà présenté par le passé le même type d'éruption après avoir touché une plante.

Le diagnostic le plus probable est :

1. Dermatite atopique
2. Dermatite de contact
3. Impetigo
4. Eczéma nummulaire
5. Infection à herpès zoster

30



30

Un garçon de 8 ans se présente avec une éruption prurigineuse aiguë sur les bras et les jambes caractérisée par des papules, des tâches et des vésicules alignées de façon linéaire. Il a déjà présenté par le passé le même type d'éruption après avoir touché une plante.

Le diagnostic le plus probable est :

1. Dermatite atopique
2. Dermatite de contact
3. Impetigo
4. Eczéma nummulaire
5. Infection à herpès zoster

31

Un petit garçon de 4 ans est amené chez son pédiatre car il refuse de marcher depuis qu'il s'est levé ce matin. La semaine passée, il a présenté une infection des voies aériennes supérieures. Il a joué au football la veille. Sa température est de 37.2 °C. Son status est dans la norme à part une limitation douloureuse de l'abduction et de la rotation externe de la hanche droite. Sa formule sanguine montre: leucocytes 11.2 G/l (norme: 4.5-11) avec 6 % de neutrophiles non segmentés. La CRP est à 25 mg/l (norme: <10). L'ultrasonographie de la hanche montre un épanchement intra-articulaire de faible importance.

Quel est le diagnostic le plus probable?

1. une arthrite septique
2. une maladie de Perthes
3. une arthrite chronique juvénile
4. un sarcome d'Ewing
5. une synovite transitoire de la hanche

31

Un petit garçon de 4 ans est amené chez son pédiatre car il refuse de marcher depuis qu'il s'est levé ce matin. La semaine passée, il a présenté une infection des voies aériennes supérieures. Il a joué au football la veille. Sa température est de 37.2 °C. Son status est dans la norme à part une limitation douloureuse de l'abduction et de la rotation externe de la hanche droite. Sa formule sanguine montre: leucocytes 11.2 G/l (norme: 4.5-11) avec 6 % de neutrophiles non segmentés. La CRP est à 25 mg/l (norme: <10). L'ultrasonographie de la hanche montre un épanchement intra-articulaire de faible importance.

Quel est le diagnostic le plus probable?

1. une arthrite septique
2. une maladie de Perthes (nécrose aseptique de la tête fémorale)
3. une arthrite chronique juvénile
4. un sarcome d'Ewing
5. une synovite transitoire de la hanche

32

Une fillette de 3 ans se présente à votre consultation. La maman vous explique qu'elle a eu de la fièvre quotidiennement depuis 7 jours, surtout la nuit. A l'examen clinique, elle a des lèvres sèches et érythémateuses, une langue framboisée, une conjonctivite bilatérale, un érythème multiforme, des adénopathies cervicales et une splénomégalie.

Un examen sanguin révèle une anémie et une leucocytose. Un strepto test rapide est négatif. Le facteur rhumatoïde, FAN, ASLO et sérologies pour la maladie de Lyme sont négatifs. La radiographie du thorax est négative.

Quel est le diagnostic le plus probable chez cet enfant?

1. Mononucléose
2. Maladie de Lyme
3. Rougeole
4. Maladie de Kawasaki
5. Scarlatine

32

Une fillette de 3 ans se présente à votre consultation. La maman vous explique qu'elle a eu de la fièvre quotidiennement depuis 7 jours, surtout la nuit. A l'examen clinique, elle a des lèvres sèches et érythémateuses, une langue framboisée, une conjonctivite bilatérale, un érythème multiforme, des adénopathies cervicales et une splénomégalie.

Un examen sanguin révèle une anémie et une leucocytose. Un strepto test rapide est négatif. Le facteur rhumatoïde, FAN, ASLO et sérologies pour la maladie de Lyme sont négatifs. La radiographie du thorax est négative.

Quel est le diagnostic le plus probable chez cet enfant?

1. Mononucléose
2. Maladie de Lyme
3. Rougeole
4. Maladie de Kawasaki
5. Scarlatine

33

Un nourrisson de 6 mois a depuis quelques jours une fièvre de 40 °C. Il est très irritable et sa fontanelle est tendue. La ponction lombaire pratiquée au 3e jour est normale. Au 4e jour apparaît sur le tronc un exanthème formé de petites taches rouge clair. L'enfant devenant en même temps afébrile.

Quel est le diagnostic le plus probable?

1. une rougeole
2. une rubéole
3. une roséole (exanthème subit)
4. une infection virale à Coxsackie
5. une scarlatine

33

Un nourrisson de 6 mois a depuis quelques jours une fièvre de 40 °C. Il est très irritable et sa fontanelle est tendue. La ponction lombaire pratiquée au 3e jour est normale. Au 4e jour apparaît sur le tronc un exanthème formé de petites taches rouge clair. L'enfant devenant en même temps afébrile.

Quel est le diagnostic le plus probable?

1. une rougeole
2. une rubéole
3. une roséole (exanthème subit)
4. une infection virale à Coxsackie pied min bouche —> été
5. une scarlatine

34

Vous êtes appelé à la maternité pour évaluer un nouveau-né à terme de 6 heures de vie qui a développé une tachypnée à 100/minutes. Il présente un grunting et une rétraction sus-sternale mais pas de cyanose. L'auscultation pulmonaire est propre sans ronchis ni râles. La radiographie du thorax montre une accentuation de la trame broncho-vasculaire. La silhouette cardiaque est normale.

Lequel des diagnostics suivant est le plus probable?

1. Maladie des membranes hyalines
2. Tachypnée transitoire du nouveau-né
3. Aspiration méconiale
4. Pneumonie virale
5. Insuffisance cardiaque

34

Vous êtes appelé à la maternité pour évaluer un nouveau-né à terme de 6 heures de vie qui a développé une tachypnée à 100/minutes. Il présente un grunting et une rétraction sus-sternale mais pas de cyanose. L'auscultation pulmonaire est propre sans ronchis ni râles. La radiographie du thorax montre une accentuation de la trame broncho-vasculaire. La silhouette cardiaque est normale.

Lequel des diagnostics suivant est le plus probable?

1. Maladie des membranes hyalines
2. Tachypnée transitoire du nouveau-né
3. Aspiration méconiale
4. Pneumonie virale
5. Insuffisance cardiaque